

04

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

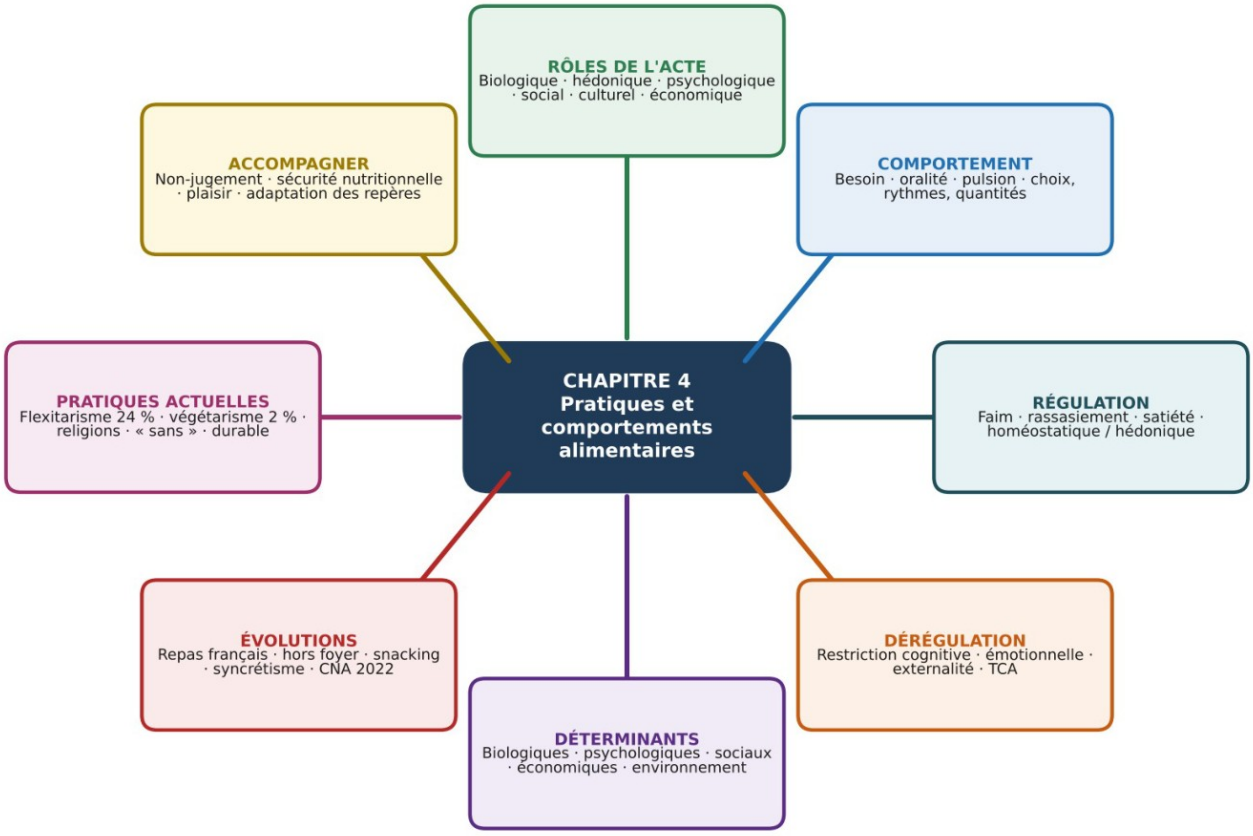
- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 4 3
1. Les définitions à savoir 3
2. Les rôles de l'acte alimentaire 3
3. Pratiques et vigilance 4
4. Chiffres-clés 4
5. Les pièges 4
6. Auto-test 4
7. Flashcards 4
Compléments du chapitre enrichi 5
Fiches-outils du chapitre 4 5
O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe 5
O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété 6
O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire 6
O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe 6
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir 7

Fiche de révision du chapitre 4

Pratiques et comportements alimentaires



Carte mentale du chapitre 4

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Comportement alimentaire	Conduites vis-à-vis de l'alimentation : choix, prises, rythmes, quantités, contexte
Faim / rassasiement / satiété	Avant (ghréline) / pendant, arrêt de la prise (CCK, distension) / après, jusqu'au repas suivant (GLP- 1, PYY, insuline, leptine)
Régulation homéostatique / hédonique	Hypothalamus, équilibre énergétique / récompense, dopamine, plaisir
Restriction cognitive	Règles mentales au lieu des sensations (Herman et Polivy, 1975)
Externalité	Manger en réponse à des signaux extérieurs
Syncrétisme culinaire	Combinaison de cultures culinaires
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande (24 % en 2020)

2. Les rôles de l'acte alimentaire

Biologique · hédonique · psychologique · social · culturel et identitaire · économique.

3. Pratiques et vigilance

Pratique	Point de vigilance clé
Végétarisme	Fer (+ vitamine C), oméga-3, zinc, iode
Végétalisme	Vitamine B12 : supplémentation obligatoire ; calcium, vitamine D, iode, protéines
Religions	Respect des interdits ; Ramadan : hydratation, repas de rupture équilibré
« Sans gluten » sans diagnostic	Pas de bénéfice démontré, surcoût
Régimes à la mode, jeûne	Restriction, carences, TCA

4. Chiffres-clés

- Part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) (Insee, 2015) ; 12,5 % en 2025 pour les seuls aliments et boissons non alcoolisées (Insee, 2026).
- 2 % de végétariens/végétaliens, 24 % de flexitariens, 8 % limitant la viande (Ifop/FranceAgriMer, 2020).
- Néophobie maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions.
- Repas gastronomique des Français : UNESCO 2010.

5. Les pièges

Attention

- Confondre rassasiement et satiété.
- Prescrire ou encourager des régimes restrictifs en santé publique.
- Classer des aliments en « interdits ».
- Juger une pratique (végétarisme, religion) au lieu de la sécuriser.
- Poser un diagnostic de TCA (on repère et on oriente).

6. Auto-test

1. Hormone de la faim ? 2. Hormone des réserves ? 3. Moment du rassasiement ? 4. Étapes du cercle de la restriction ? 5. Nutriment à supplémenter chez le végétalien ? 6. Part des flexitariens ? 7. Qu'est-ce que l'externalité ? 8. Deux conseils pour favoriser le rassasiement ? 9. Que signifie ARFID ? 10. Exemple de syncrétisme ?

Réponses : 1. Ghréline – 2. Leptine – 3. Pendant le repas – 4. Insatisfaction, restriction, frustration, craquage, culpabilité, reprise de poids – 5. Vitamine B12 – 6. 24 % – 7. Manger selon des signaux extérieurs – 8. Manger lentement, fibres et protéines, sans écran – 9. Trouble de restriction/évitement de l'ingestion des aliments – 10. Couscous aux légumes de saison français.

7. Flashcards

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Environnement obésogène ?	Verso : Portions, offre palatable, marketing, sédentarité
Recto : Loi d'Engel ?	Verso : La part de l'alimentation dans le budget baisse quand le revenu augmente
Recto : Recommandations HAS TCA ?	Verso : Anorexie mentale (2010) ; boulimie et hyperphagie boulimique (2019)

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Cinq principes d'accompagnement ?	Verso : Comprendre, respecter, partir de l'existant, plaisir, sécuriser et orienter
Recto : Facilitation sociale ?	Verso : On mange plus à plusieurs : utile contre la dénutrition

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Rythmes	Repas, collation (prévue, faim), grignotage ; petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; pas de collation à 10 h si petit-déjeuner (AFSSA, 2004)
Enfant	Diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; Satter : parent quoi/quand/où, enfant si/combien
Mesure	Rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes
Durabilité	FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019, mise à jour 2025) ≈ 14 g/jour de viande rouge ; bœuf ≈ 50 × lentilles en CO2e par portion ; gaspillage ≈ 3,8 Mt comestibles en 2023 (SDES)
TCA	Anorexie ≈ 0,9 % des femmes, boulimie ≈ 1,5 %, hyperphagie ≈ 3,5 % (vie entière) ; prévention sans poids ; repérer et orienter (FFAB)
Précarité	Stratégies : qualité sacrifiée, priorité aux enfants, faire durer, aide alimentaire, plaisir préservé ; reconnaître les compétences

Fiches-outils du chapitre 4

Outil	Intitulé	Utilité
O4.1	Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe	Adapter l'action aux pratiques (régimes, religions, rythmes)
O4.2	Échelle de la faim et de la satiété	Atelier sensations (enfants, adultes)
O4.3	Grille d'analyse d'un comportement alimentaire	Identifier déterminants et dérégulations
O4.4	Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe	Choisir des recettes communes
O4.5	Repérage et orientation (signes d'alerte)	Conduite à tenir en action collective

O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Sans porc / halal		
Casher		
Végétarien / pescétarien		
Végétalien		
Jeûne (période, horaires)		
Allergies (préciser)		
Intolérances, maladie cœliaque		
Textures adaptées		

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Autre		

Recueil avec l'accord des personnes ; données de santé à protéger (RGPD).

O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété

Niveau	Ce que je ressens	Que faire ?
0	Très faim, malaise, irritabilité	Manger sans attendre
2	Faim nette, ventre qui gargouille	C'est le bon moment pour manger
4	Petit creux	Je peux manger ou attendre un peu
5	Ni faim ni rassasié	Pas besoin de manger
7	Rassasié, satisfait	C'est le bon moment pour s'arrêter
9	Trop mangé, ventre lourd	Repérer ce qui m'a poussé à continuer
10	Mal, nausée	Prendre le temps la prochaine fois

O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire

Rubrique	Observations
Comportement observé (quoi, quand,	
combien, où, avec qui)	
Rôles de l'acte alimentaire en jeu	
Régulation (faim, rassasiement, satiété	
respectés ?)	
Dérégulations possibles (restriction,	
émotionnelle, externalité, grignotage)	
Déterminants (biologiques,	
psychologiques, sociaux, économiques,	
environnement)	
Leviers éducatifs et environnementaux	
Signes d'alerte nécessitant une	
orientation	

orientation

O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe

Recette	Sans porc / halal	Végétarien	Végétalien	Sans gluten	Sans lait	Allergènes à signaler
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	

O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir

Signe observé ou confié	Conduite à tenir
Perte de poids importante, restriction sévère, peur intense de grossir	Ne pas commenter devant le groupe ; en parler en privé avec bienveillance ; informer le référent de la structure ; orienter vers le médecin traitant
Crises de « craquage », vomissements, utilisation de laxatifs	Même conduite ; informer des ressources (médecin, structures spécialisées en TCA)
Perte d'appétit et de poids chez une personne âgée	Signaler (avec accord) au médecin traitant ou au service d'aide ; proposer une pesée
Pathologie déclarée (diabète, insuffisance rénale…)	Orienter vers une consultation diététique (BC1), ne pas prescrire de régime
Détresse psychologique	Informer immédiatement le référent ; ressources d'écoute ; ne pas rester seul(e)